

PAUSE AR | |

Nouveautés de la semaine du 12 septembre 2026

5 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE Essai randomisé

Total Intravenous vs Volatile Inhalational Anesthesia for Major Noncardiac Surgery: A Randomized Clinical Trial

JAMA · 12 août 2026 · Essai randomisé pragmatique multicentrique, 2 508 adultes de 50 ans et plus

Chez 2 508 adultes de 50 ans et plus opérés d'une chirurgie majeure non cardiaque programmée, entretenir l'anesthésie au propofol ou avec un agent halogéné aboutit au même nombre de jours vivant et à domicile à 30 jours : 22,5 contre 22,4 jours. Mortalité, qualité de la récupération et confusion postopératoire étaient comparables. Soif, enrouement, nausées et vomissements étaient moins fréquents sous anesthésie intraveineuse ; en revanche, les deux seuls cas de mémorisation peropératoire rapportés sont survenus dans ce groupe.

En pratique : le choix entre propofol et halogéné pour l'entretien d'une anesthésie générale en chirurgie majeure non cardiaque peut se faire sur d'autres critères que la récupération globale, qui est la même. Les arguments restent le confort postopératoire immédiat, où la voie intraveineuse garde un avantage modeste, et la surveillance de la profondeur d'anesthésie sous perfusion de propofol — même si deux cas de mémorisation, sur plus de mille deux cents patients, ne permettent aucune conclusion chiffrée. Il n'y a pas lieu d'imposer l'une ou l'autre technique dans un protocole de service au nom du devenir du patient.

[Article original](#)

ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE Méta-analyse · BREATHE-CS

Perioperative mechanical ventilation strategies in adult cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a meta-analysis of randomised controlled trials

Br J Anaesth · 27 août 2026 · 105 essais recensés, 39 analysés

Les complications pulmonaires sont fréquentes après chirurgie cardiaque, et de nombreuses stratégies ventilatoires ont été essayées pour les prévenir, sans conclusion claire. Cette méta-analyse a recensé 105 essais randomisés portant sur la ventilation avant, pendant ou après une chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle, et en a rassemblé 39 pour l'analyse quantitative, la mortalité toutes causes étant le critère principal. Aucune des comparaisons rapportées ne réduit significativement la mortalité ; le seul résultat net porte sur un critère secondaire, les complications pulmonaires postopératoires, moins nombreuses lorsque la ventilation est maintenue pendant la circulation extracorporelle plutôt que le respirateur arrêté. Les autres stratégies comparées n'ont pas montré de bénéfice.

En pratique : maintenir une ventilation pendant la circulation extracorporelle, au lieu de laisser les poumons au repos respirateur arrêté, est la seule stratégie associée dans cette synthèse à moins de complications pulmonaires postopératoires — sur un critère secondaire, et sans effet démontré sur la mortalité. C'est un geste simple, à discuter avec l'équipe de perfusion. Le choix entre pression contrôlée et volume contrôlé peut rester affaire d'habitude, et l'assistance non invasive après extubation ne peut pas être recommandée sur ces données pour améliorer la survie.

[Article original](#)

Hypotension Prediction Index versus Mean Arterial Pressure Alarm for Preventing Intraoperative Hypotension in Elective Non-Cardiac Surgery: A Randomized Controlled Trial

Anesthesiology · 19 août 2026 · 143 patients, monocentrique, en aveugle

L'indice de prédiction de l'hypotension est proposé pour anticiper les chutes tensionnelles au bloc, mais il suit de très près la pression artérielle moyenne elle-même. Cet essai monocentrique en aveugle a comparé, chez 143 adultes opérés d'une chirurgie non cardiaque programmée à risque modéré ou élevé, une simple alarme déclenchée sous 72 mmHg de pression moyenne à l'alarme de l'indice réglée au-dessus de 85. L'exposition à l'hypotension, mesurée par l'aire sous le seuil de 65 mmHg, était comparable dans les deux groupes et l'alarme simple remplit le critère de non-infériorité fixé d'avance.

En pratique : pour surveiller la pression artérielle au bloc, une alarme réglée sous 72 mmHg expose le patient à autant, et pas plus, d'hypotension que l'indice de prédiction, dans une population opérée d'une chirurgie non cardiaque avec cathéter artériel. Cela invite à ne pas considérer l'indice comme indispensable là où il n'est pas disponible. L'essai reste petit et monocentrique : il ne tranche pas la question du bénéfice clinique de l'une ou l'autre stratégie sur les complications postopératoires.

[Article original](#)

Risk assessment and prevention of postoperative and postprocedural respiratory failure: recommendations from an international expert panel

Br J Anaesth · 31 juillet 2026 · 25 experts, 13 recommandations et 15 suggestions

L'insuffisance respiratoire après une intervention, définie par un recours non prévu à la ventilation invasive ou non invasive, n'avait jusqu'ici fait l'objet d'aucun texte d'orientation dédié. Un groupe pluridisciplinaire de 25 experts a examiné la littérature, comblé les lacunes par avis d'experts et soumis 54 propositions initiales à des tours de vote successifs, pour aboutir à 13 recommandations d'application large et 15 suggestions à appliquer au cas par cas. Les mesures retenues portent sur le dépistage systématique du risque et sur des gestes simples de la période postopératoire.

En pratique : ce texte donne, à défaut de recommandations fondées sur des essais, une liste cohérente de mesures applicables dès la consultation d'anesthésie et en salle de surveillance post-interventionnelle : dépistage outillé du risque respiratoire, arrêt du tabac, report d'une intervention en cas d'infection respiratoire symptomatique, lever précoce, position redressée, soins de bouche, assistance respiratoire non invasive et sédation allégée. La faisabilité de mise en œuvre faisait partie des critères de sélection du groupe. Leur bénéfice combiné attend en revanche d'être confirmé par des travaux dédiés.

[Article original](#)

Consensus guideline from the European Malignant Hyperthermia Group on perioperative management of patients with an inherited primary disorder of skeletal muscle

Br J Anaesth · 30 juillet 2026 · recommandations de consensus

Les anomalies périopératoires des patients atteints d'une maladie musculaire héréditaire ressemblent parfois à une crise d'hyperthermie maligne, et la littérature disponible sur leur prise en charge est contradictoire et souvent dépassée. Le Groupe européen d'hyperthermie maligne (EMHG) publie des recommandations issues d'une revue de la littérature et d'un processus formel de consensus. Le texte associe des recommandations générales, valables pour toute myopathie nécessitant une anesthésie ou une sédation procédurale, et des recommandations propres à chaque grande famille de myopathie.

En pratique : ce texte devient la référence à ouvrir en consultation pré-anesthésique devant une maladie musculaire héréditaire, plutôt que de se fier à des avis anciens ou divergents. Il invite à identifier précisément la myopathie en cause, puisque la conduite proposée diffère d'une famille à l'autre. Sa lecture intégrale est nécessaire : les recommandations générales ne dispensent pas des points de vigilance propres à chaque affection.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : pausear.fr

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.